Prévalences · contrôle statistique et erreurs

18.10.2026 à 21:39 · Europe/Zurich

Synthèse centralisée par le calculateur des jauges. Ce rapport décrit le dispositif et ses candidats ; il ne constitue pas une validation médicale.

1. Progression par catégorie

Catégorie	DD	Recherches abouties	Extraits candidats	Chiffres publiés sourcés
G	238	0	78	15
S	1025	0	92	28
F	577	0	97	2
O	747	0	131	0

12 SSP sur 248 n’ont pas encore de différentiel. Les candidats ne font jamais monter la couverture clinique.

2. Règle de sélection des valeurs

Vérifier la source reconnue, la définition du diagnostic, le pays réel des participants, la période, les âges et le cadre. Comparer ensuite la qualité méthodologique et le risque de biais ; à qualité comparable, privilégier le plus grand effectif effectivement analysé. Un grand échantillon biaisé ne devient pas représentatif par sa taille.

Aucune moyenne n’est calculée entre populations incompatibles. Incidence, risque, OR/HR, intervalle de confiance et prévalence sont distingués. Les plans pondérés ou en grappes exigent une précision tenant compte du plan. Une valeur retenue reste une proposition à relire, pas une écriture clinique automatique.

3. Décompte des contrôles et corrections

Échecs d’accès ou de recherche : 919

Réserves d’accès de l’agent par candidat : 2

Points candidats à vérifier : 410

Réserves de sélection : 398

Corrections arithmétiques des candidats : 0

Défauts du dispositif corrigés : 12

Relectures documentaires consignées : 35

Sources inaccessibles pendant la relecture de l’agent

Ces candidats restent à relire. Plusieurs extraits peuvent renvoyer au même article ; un refus d’accès ne compte jamais comme une relecture terminée.

O · O1.1#1 · candidat 9ee2472232d199f9b547422c

Accès direct au DOI tenté : CONNECT 403. Aucun texte source relu ni effectif déduit. Le candidat reste en file.

https://doi.org/10.24095/hpcdp.36.7.01f
18.10.2026 à 18:05 · Europe/Zurich

O · O1.1#1 · candidat b8f876bdda501cfba29d788c

Accès direct au DOI tenté : CONNECT 403. Aucun texte source relu ni effectif déduit. Le candidat reste en file.

https://doi.org/10.24095/hpcdp.36.7.01f
18.10.2026 à 18:05 · Europe/Zurich

Points à vérifier, échecs réseau et corrections confirmées sont comptés séparément ; aucune erreur médicale publiée ne se déduit d’une piste rejetée.

4. Erreurs corrigées et contrôle de l’agent

COORD-ARRONDI

La clôture pouvait utiliser100% arrondi malgré des données manquantes.

Avant : 2575/2587 arrondi à100%
Après : Compte exact et documentation couplée exigés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/feat/coordination-8-9/tests/test_prevalences_coordination.py

COORD-BOOL-DATE

Un booléen et une date future pouvaient compter comme prévalence.

Avant : True et date future acceptés par la jauge globale
Après : Nombre fini hors booléen, date valide et emplacement textuel exigés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/feat/coordination-8-9/tests/test_prevalences_coordination.py

COORD-NULL

Les champs nuls pouvaient être comptés comme rubriques remplies.

Avant : str(None) accepté
Après : Chaîne non vide exigée
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/feat/coordination-8-9/tests/test_prevalences_coordination.py

acces-agent-centralises

Les refus de source rencontrés par l’agent étaient conservés dans les candidats mais omis du registre central et du PDF.

Avant : Statut source_inaccessible absent des compteurs et de la synthèse PDF
Après : Nature acces_relecture distincte avec source, date et motif ; passage PDF dédié ; aucune lecture terminée ni correction supposée
tests/test_prevalences_rapport.py : test_inaccessible_agent_sources_are_not_completed_reviews ; test_agent_access_refusals_are_in_pdf_outside_limited_network_examples

bruit-prepositions

La préposition par créait des faux rapprochements, dans huit des neuf pistes de la catégorie O. Ces pistes ont été relues et non publiées.

Avant : Préposition prise pour un terme diagnostique
Après : Mots grammaticaux exclus ; source et rejet conservés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/automates/prevalences/agent-relecture-initiale.json

conservation-relectures

Un rafraîchissement pouvait remplacer les annotations statistiques antérieures. Les preuves liées à la même source sont désormais conservées.

Avant : Remplacement du candidat portant le même identifiant
Après : Réunion des découvertes et des relectures liées à l’empreinte
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

decimales-intervalles

L’extraction pouvait isoler 69 % dans une écriture 4, 69 %, ou la borne 35 % dans un intervalle 10–35 %. Le texte numérique exact est désormais conservé.

Avant : Fragment numérique pris isolément
Après : Décimale espacée, bornes et intervalles conservés verbatim ; aucune valeur ponctuelle inventée
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

pdf-double-comptage

La relecture indépendante du PDF de travail a détecté un double comptage entre anciennes signatures et événements actifs. Défaut corrigé avant le déploiement de la synthèse.

Avant : Archives de la même erreur additionnées aux erreurs actives
Après : Migration sémantique des signatures, déduplication et décomptes actifs/archives séparés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/main/tests/test_prevalences_rapport.py

protocole-jauge

Une seule requête réussie pouvait être comptée comme une recherche aboutie. Le protocole entier sans doublons est maintenant exigé.

Avant : Test all(ok) sur une liste incomplète
Après : Ensemble attendu des requêtes vérifié ; états partiels distincts
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

relecture-perimee-rapport

Un statut terminé seul pouvait faire compter une relecture portant sur une ancienne empreinte. La synthèse vérifie désormais la preuve complète de relecture actuelle.

Avant : Comptage du statut terminé sans contrôle de source
Après : review_completed exigé ; relecture périmée archivée, sans validation clinique
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/blob/main/tests/test_prevalences_rapport.py

sigles-medicaux

Les diagnostics courts comme VIH ou BPCO n’étaient pas repérés. Une correspondance par mots entiers est maintenant testée.

Avant : Exclusion des tokens courts
Après : Sigles médicaux admis avec bornes de mots
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

source-concurrente

Un artefact plus ancien pouvait remplacer une source plus récente et sa relecture. La consolidation préserve la source récente.

Avant : Fusion aveugle d’artefacts différés
Après : Dates et empreintes comparées ; artefacts obsolètes ignorés et comptés
https://github.com/vialdjoukang-spec/organigramme-examen-federal/pull/104

5. Exemples de réserves encore ouvertes

Exemples limités pour garder une synthèse lisible. Le registre JSON conserve la liste complète ; une absence dans cette sélection ne signifie pas qu'un problème est résolu.

F · F1.1#0 · À vérifier

5 à <10 % est une strate de risque SCORE2/SCORE2-OP utilisée pour considérer un traitement, pas une prévalence du DD.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

10 % désigne les HTA secondaires, alors que le DD recherché est l'HTA primaire ; dénominateur composé de cas d'HTA, population géographique non précisée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

10–20 % concerne l'HTA résistante chez des patients déjà hypertendus malgré traitement ; 20 % seul efface l'intervalle et le contexte.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

13 % concerne les décès attribuables à l'HTA. L'extrait voisin mentionne 90 % de formes primaires parmi les HTA, qui utilise un autre dénominateur.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

Jusqu'à 20 % concerne l'HTA de blouse blanche et représente une borne supérieure, pas une estimation exacte d'HTA primaire parmi les consultants.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

90 % concerne les formes primaires parmi les cas d'HTA, pas tous les patients consultant pour pression artérielle anormale ; ni population CH/Europe ni effectifs attestés ici. L'origine HUG du document ne suffit pas à attribuer ce chiffre à une cohorte suisse.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

Moins de 50 % concerne le contrôle de l'HTA sous traitement chez des patients d'origine africaine ; ce n'est pas la fréquence d'HTA primaire parmi les consultants.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

Jusqu'à 50 % concerne l'HTA secondaire chez les patients atteints d'HTA réfractaire ; ni diagnostic primaire ni dénominateur général des consultants.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

50 % désigne les hypertendus traités ; le dénominateur est une population déjà hypertendue. Le chiffre ne mesure pas la prévalence d'HTA primaire parmi les consultants.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

13 % désigne la part des décès mondiaux attribuable à l'HTA, pas la prévalence du diagnostic parmi les patients consultant pour pression artérielle anormale.

https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#0 · À vérifier

Le texte donne un intervalle 10–35 % d'HTA secondaire et jusqu'à 50 % chez les HTA réfractaires ; 35 % isolé n'est pas une estimation ponctuelle de l'HTA primaire.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2025-09/strategie_hypertension_2025_2.pdf

F · F1.1#2 · À vérifier

La source indique un intervalle de 8 à 16 % de maladie rénale chronique dans la population mondiale. Le fragment 16 % est une borne, pas une estimation de sténose de l'artère rénale parmi les consultants pour pression artérielle anormale ; population CH/Europe non isolée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2024-10/strategie_maladie_renale_chronique_doi.pdf

F · F1.1#2 · À vérifier

Plus de 60 % concerne ensemble diabète et hypertension parmi les causes de maladie rénale chronique. Ce chiffre agrégé ne peut être réparti arbitrairement, ni transféré à une sténose de l'artère rénale ou à une prévalence de consultation.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2024-10/strategie_maladie_renale_chronique_doi.pdf

F · F1.1#2 · À vérifier

10,4 % est une estimation de maladie rénale chronique en Suisse. Le caractère suisse est explicite, mais il ne rend pas cette valeur applicable à la sténose de l'artère rénale ni au dénominateur des consultations pour pression artérielle anormale.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2024-10/strategie_maladie_renale_chronique_doi.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Jusqu'à 21 % est une borne de fréquence de bactériémie parmi des prostatites fébriles ; ce diagnostic et ce dénominateur sont incompatibles avec la question VIH dans G1. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Les 12 % sont une proportion de stade au diagnostic parmi des infections déjà dépistées. Ce n'est pas la fréquence du VIH parmi des personnes consultant pour sudation anormale. Ne pas reconstruire un numérateur avec le total annuel arrondi. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.sfdermato.org/upload/recommandations/primo-infection-vih-8dafd3bbea5f8ac1933dda9fbcd8628b.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Près de 80 % décrit des manifestations cliniques quelconques parmi les infections récentes. Les sueurs nocturnes figurent ensuite parmi les symptômes possibles mais leur fréquence propre n'est pas donnée. Ne pas inverser P(symptômes|VIH) en P(VIH|sudation). ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.sfdermato.org/upload/recommandations/primo-infection-vih-8dafd3bbea5f8ac1933dda9fbcd8628b.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Le 95 % décrit la sensibilité du test de leucocyturie ; aucune prévalence du VIH ne peut être déduite. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

G · G1#8 · À vérifier

77 % à 90 % forme une plage de fréquence de signes prostatiques, dont le moteur a découpé les bornes. Ni la borne basse ni la plage ne mesurent le VIH parmi les consultations pour sudation. ; Source documentaire

reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Jusqu’à 23 % concerne la non-détection par examen de prostatites ; ne pas calculer ni transposer ce complément en fréquence de VIH. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Le 90 % est une sensibilité de la bandelette urinaire, pas une fréquence du VIH ni un résultat parmi des consultations pour sudation anormale. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Les 20 % concernent un sous-groupe de dépistage VIH, pas les HSH en général ni les consultations G1. Le total annuel 7000 n’est pas le dénominateur de ce sous-groupe. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.sfdermato.org/upload/recommandations/primo-infection-vih-8dafd3bbea5f8ac1933dda9fbcd8628b.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Le 90 % est la borne supérieure de la même plage 77 % à 90 %, pas une estimation indépendante ni une prévalence du VIH. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

G · G1#8 · À vérifier

Le 65 % est une spécificité de bandelette urinaire. Le dénominateur ne porte ni sur le VIH ni sur les consultations pour sudation anormale. ; Source documentaire reconnue ne suffisant pas à établir une population ou un dénominateur pertinent pour G1 ; aucune valeur proposée.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2026-10/strategie-infection-urinaire-finale.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

FEVG normale >55 % est une mesure physiologique, pas une prévalence ; aucun diagnostic placentaire. Appariement lexical sur la préposition « par » corrigé dans le moteur.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

21 % concerne la réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque sous traitement, pas une prévalence d’insuffisance placentaire.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

25 % concerne une réduction de mortalité/hospitalisations sous empagliflozine, pas une prévalence ; population d’insuffisance cardiaque hors cible placentaire.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

FEVG ≥50 % est un seuil de classification cardiologique, pas une prévalence ; aucun diagnostic placentaire. Faux appariement lexical « par » corrigé.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

FEVG ≤40 % est un seuil de fonction ventriculaire dans un document d’insuffisance cardiaque ; aucun retard de croissance placentaire. Appariement lexical sur « insuffisance » trop général.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

FEVG ≤40 % est un seuil de classification cardiologique, pas une prévalence ; aucun diagnostic placentaire. Faux appariement lexical « par » corrigé.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

Le PDF indique « risque absolu de 4, 69% » dans un contexte thérapeutique ; le repérage isolé « 69% » fragmente la décimale 4,69 %. Aucun chiffre de prévalence placentaire ne peut en être déduit.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

20 % concerne une réduction relative de risque sous sacubitril/valsartan (HR 0,80), pas une prévalence ; diagnostic d’insuffisance cardiaque hors cible placentaire.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

O · O1.1#0 · À vérifier

FEVG <40 % décrit un critère de population cardiologique de l’essai, pas la fréquence d’un retard de croissance placentaire.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2022-12/strategies_insuffisance_cardiaque.pdf

S · S1.1#1 · À vérifier

50–70 % concerne la paralysie faciale idiopathique de Bell (nerf VII), alors que le DD recherché concerne le nerf oculomoteur III. Ni diagnostic ni dénominateur ne sont transférables.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2023-04/paralysie_faciale_peripherique_avril_2023_1.pdf

S · S1.1#2 · À vérifier

50–70 % concerne la paralysie faciale idiopathique de Bell (nerf VII), pas les paralysies des nerfs abducens VI ou trochléaire IV. L’intervalle ne fournit pas une fréquence applicable à ces diagnostics.
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/2023-04/paralysie_faciale_peripherique_avril_2023_1.pdf

Registre : prevalences-erreurs.json · Jauges : prevalences.html · Les identifiants et sources permettent de reproduire le contrôle.